

Santé publique — Introduction à la santé publique

M1 — Santé Publique | Fiche de synthèse visuelle — d'après la fiche de cours n°1 (partie 1)

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence). Le gras signale les points clés à retenir en priorité.

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 36 notions ci-dessous sont celles marquées par le concours dans ce chapitre (fiche de cours n°1, partie 1), d'après les icônes de priorité concours de la fiche source. À maîtriser en priorité absolue.

1	★★	Selon René Leriche (1936), « la santé c'est la vie dans le silence des organes ».	p.1
2	★★	Selon l'OMS, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social.	p.2
3	★	Selon l'OMS, la santé ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité.	p.2
4	★	Selon l'OMS, la santé est une ressource pour chaque jour de la vie et non une finalité de la vie.	p.2
5	★	La frontière entre le normal et le pathologique varie avec l'âge, la culture et l'état de la science.	p.2
6	★	Le concept de santé positive met l'accent sur l'hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.	p.2
7	★	La santé positive met l'accent sur l'importance de stratégies larges prenant en compte une combinaison de déterminants.	p.2
8	★★	Selon la Conférence d'Ottawa (1986), la promotion de la santé confère aux populations les moyens d'un plus grand contrôle sur leur santé et de l'améliorer.	p.2
9	★	Selon l'OMS (1952), la santé publique vise notamment à améliorer la santé des individus.	p.3
10	★	Selon l'OMS (1952), la santé publique agit par le moyen d'une action collective concertée.	p.3
11	★	Selon l'OMS (1952), la santé publique vise notamment à organiser des services médicaux en vue du diagnostic précoce et du traitement préventif des maladies.	p.3
12	★	La vaccination contre la variole a été mise au point par Edward Jenner en 1796, sur le principe d'inoculation.	p.4
13	★	Le courant hygiéniste (19e-début 20e s.) correspond à l'émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.	p.4
14	★	La loi relative à la protection de la santé publique (1902) a introduit le concept de santé publique en France.	p.4
15	★	La mission de santé publique se décline selon la règle des 5P : Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision.	p.5
16	★	Dans la règle des 5P, la Prévention vise à éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage).	p.5
17	★	Contrairement à la médecine clinique, la santé publique s'intéresse à la population, à des groupes de personnes.	p.6
18	★	Les indicateurs de santé sont le moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.	p.6
19	★	La fiabilité (ou reproductibilité) est l'une des propriétés des indicateurs de santé.	p.7
20	★	Les facteurs de risque font partie des différents types d'indicateurs de santé.	p.7
21	★	La centralisation et l'analyse des causes de décès constituent une source de données en santé publique en France.	p.8
22	★	Le CépiDc est une source de données sur les causes de décès en France.	p.8
23	★	L'Inserm est, avec le CépiDc, une source de données sur les causes de décès en France.	p.8
24	★	La prévalence est un indicateur de morbidité en épidémiologie descriptive.	p.11
25	★★	Le nombre de cas sur une période de temps ou à un moment donné correspond à la prévalence.	p.11
26	★	L'incidence est un indicateur de morbidité en épidémiologie descriptive.	p.11
27	★★	Le nombre de nouveaux cas correspond à l'incidence.	p.11
28	★	L'incidence se mesure sur une période de temps.	p.11
29	★	L'incidence informe sur la dynamique de la maladie.	p.11
30	★	La létalité est un indicateur de morbidité en épidémiologie descriptive.	p.11
31	★★ ★	Le nombre de décès parmi les malades correspond à la létalité.	p.11
32	★	En épidémiologie descriptive, la mortalité correspond au nombre de décès.	p.11
33	★★	En 2024, le nombre de décès en France s'élève à 646 000, en augmentation de 6 700 par rapport à 2023.	p.12
34	★★	En 2022, les tumeurs représentent environ 27 % des décès et sont la 1ère cause de mortalité chez les hommes.	p.13
35	★	En 2022, les maladies cardiovasculaires représentent environ 24 % des décès et sont la 1ère cause de mortalité chez les femmes.	p.13
36	★★	L'espérance de vie désigne le nombre moyen probable d'années à vivre.	p.14

1 • LES DÉFINITIONS DE LA SANTÉ

p.1-2

● **Petit Robert** : bon état physiologique, fonctionnement régulier et harmonieux de l'organisme ; applicable à la population générale.

★★ **Leriche (1936)** : « la vie dans le silence des organes ».

● **Physiologique** : normes du fonctionnement physique/biologique (poids, mesures, capacités).

● Steichen (psychologique) : la **normalité** avec ses caractéristiques.

● Blum (santé publique) : équilibre approprié à l'âge/besoins sociaux ; **survie de l'espèce** et accomplissement personnel.

● Canguilhem (philosophique) : la santé a remplacé le salut, marge de tolérance aux infidélités du **milieu** ; « luxe biologique ».

● Dubos (microbiologie) : **état physique et mental**, exempt de gêne/souffrance, fonctionner dans son milieu.

● Bastide (sociologie) : riposter à un **monde complexe et mouvant**, le modifier plutôt que s'y ajuster.

● Cotton (1982) : rythme continu d'interactions, **état d'équilibre instable**, bien-être à reconquérir sans cesse.

★★ **OMS** : **état de complet bien-être physique, mental et social.**

★ **OMS** : **ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité.**

★ **OMS** : **ressource pour chaque jour de la vie, n'est pas une finalité de la vie.**

★ **Frontière normal/pathologique** : **varie avec l'âge, la culture, l'état de la science.**

★ **Santé positive** : **hypothèse d'un développement progressif de la maladie en étapes.**

★ **Santé positive** : **stratégies larges, combinaison de déterminants (ex. empowerment = efficacité individuelle + appuis sociaux).**

★★ **Charte d'Ottawa (1986)** : **moyens d'un plus grand contrôle sur sa santé et de l'améliorer.**

– Charte d'Ottawa : ressource de la vie quotidienne, pas le but de la vie ; concept positif (ressources sociales/individuelles, capacités physiques).

– Exemples de campagnes : mois sans tabac, « 5 fruits et légumes/jour », Dry January, résistance aux antibiotiques.

2 • DÉFINITION ET MISSIONS DE LA SANTÉ PUBLIQUE

p.3, 5

★ **OMS (1952)** : « **science et art** » de **prévenir les maladies, prolonger la vie et améliorer la santé des individus.**

★ **OMS (1952)** : **par le moyen d'une action collective concertée.**

★ **OMS (1952)** : **viser notamment à organiser des services médicaux (diagnostic précoce, traitement préventif).**

– OMS (1952), autres actions : assainir le milieu, lutter contre les maladies d'importance sociale, enseigner l'hygiène personnelle, mesures sociales de niveau de vie.

– OMS (1952) : objet final = droit inné de chaque individu à la santé et à la longévité.

● **OMS (2002)** : ensemble des efforts d'institutions publiques pour **améliorer, promouvoir, protéger et restaurer** la santé de la population, par une action collective.

★ **Règle des 5P** : **Protection, Prévention, Promotion, Prévision, Provision.**

★ **Prévention** : **éviter la survenue de maladies (vaccination, dépistage).**

– Protection : enrayer la propagation (urgences sanitaires, maladies infectieuses, risques environnementaux, santé des travailleurs).

– Promotion : habitudes de vie saines, déterminants sociaux ; Prévision : surveiller maladies/risques ; Provision : donner des soins.

● **Discipline autonome** : s'occupe de l'**état de santé** d'une collectivité/groupe = santé **globale des populations.**

3 · HISTOIRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

p.4

● Antiquité : **Serment d'Hippocrate** (déontologie), soins gratuits à l'indigent, partir loin/vite/longtemps en épidémie.

● Moyen Âge : création des **hôtels-Dieu** (ordres religieux : infirmes, vieillards, orphelins).

● Moyen Âge : **peste noire** (1347, Marseille, toute l'Europe, 30-50 % de décès) → 1ères mesures de santé publique.

★ **Vaccination contre la variole par Edward Jenner (1796, principe d'inoculation).**

★ **Courant hygiéniste (19e-début 20e s.) : émergence de l'épidémiologie, de l'hygiène et de la prévention.**

– Semmelweis : hygiène hospitalière et **asepsie**.

– Pasteur : hypothèse d'agents infectieux (tuberculose), **pasteurisation**, asepsie chirurgicale, vaccination anti-rabique.

– 1848 : Comité consultatif d'hygiène publique de France.

★ **1902 : loi relative à la protection de la santé publique (introduit ce concept en France).**

4 · COMPLÉMENTARITÉ MÉDECINE CLINIQUE / SANTÉ PUBLIQUE

p.6

● C. Everett Koop : « health care is vital to all of us some of the time, but public health is vital to all of us all of the time ».

● Médecine clinique : traite la **maladie**, prend en charge une personne (« colloque singulier »), méthodes thérapeutiques.

★ **Santé publique : traite de la santé, s'intéresse à des groupes de personnes.**

– Santé publique : promotion de la santé, prévenir l'apparition des maladies (épidémiologie, administration de la santé, sociologie), approche par populations/facteurs de risque/déterminants.

– Raisons de mesurer l'état de santé : crises sanitaires (amiante 1970, sang contaminé 1983, ESB, canicule 2003, Covid 2020), mondialisation (maladies d'importation, réémergence, SRAS/Mpox).

– Présence d'inégalités et évolution temporelle préoccupante.

5 · LES INDICATEURS DE SANTÉ

p.6-7

★ **Indicateurs de santé = moyen utilisé pour mesurer et observer l'état de santé.**

● Définition : instrument de mesure agrégeant/simplifiant/résumant des ensembles d'informations.

★ **Propriétés : disponibilité, simplicité à l'usage, exactitude, et fiabilité (reproductibilité).**

– Éléments indispensables : connaissance des problèmes de santé, prise de décision, orientation de la recherche étiologique.

– Outils de décision/intervention pour gouvernements, agences de santé publique, organisations médicales.

★ **Types : mortalité, morbidité, handicap, démographiques, et facteurs de risque (parfois ajoutés).**

6 · SOURCES DE DONNÉES EN FRANCE

p.8-9

★ **Centralisation/analyse des causes de décès : source de données en santé publique.**

★ **CépiDc (accès libre internet, causes directes/indirectes, tri par âge/sexe).**

★ **Inserm, avec le CépiDc.**

● **Registres des cancers** : identifier les cas par localisation ; population de référence = le département.

– 25 en France (14 généraux + 11 spécialisés) ; sources : anatomo-pathologistes, biologistes, cliniciens.

– Extrapolation possible : structure de population (standardisation), létalité, mortalité.

– Autres sources : certificat de santé, vigilances, système européen accidents domestiques/loisirs, enquêtes nationales, données médico-admin., Insee/INED, MDO, IARC/CRAM.

– Big data en santé : explosion des données numériques, haute technicité, bio-informatique (surveillance/détection).

7 · LA MORBIDITÉ

p.10

● **Morbidité** = maladies et pathologies.

● **3 types** : morbidité ressentie, diagnostiquée, réelle.

– Selon le genre (Insee 2002-2003) : 48,8 % en bonne santé ; hommes plus souvent en très bonne santé (28,2 % vs 21,5 %).

– Selon l'âge : la très bonne santé diminue et la mauvaise santé augmente avec l'âge.

– Paradoxe : les hommes déclarent moins souffrir de maladies, alors qu'ils sont les plus atteints.

8 · INDICATEURS DE MORBIDITÉ ET MORTALITÉ

p.11

- ★ **Prévalence** : indicateur de morbidité.
- ★★ **Nombre de cas sur une période ou à un moment donné = prévalence** (importance quantitative de la maladie).
- ★ **Incidence** : indicateur de morbidité.
- ★★ **Nombre de nouveaux cas = incidence.**
- ★ **Incidence** : se mesure sur une période de temps.
- ★ **Incidence** : informe sur la dynamique de la maladie (épidémie ou non).
- ★ **Létalité** : indicateur de morbidité.
- ★★★ **Nombre de décès parmi les malades = létalité** (gravité de la maladie).
- ★ **Mortalité** = nombre de décès.

– Taux de reproduction R : cas secondaires engendrés par un cas → **contagiosité**.

9 · LA MORTALITÉ EN FRANCE

p.12

- ★★ **600 000 à 650 000 décès/an ; en 2024, 646 000 décès (+6 700 vs 2023).**
- 2020 : 653 047 ; 2022 : 670 000 (Covid/grippe/canicule) ; 2023 : 639 300 (–5,3 %).
- Taux brut de mortalité = décès/population ; **9,4 ‰** en 2023 et 2024 (population = 68,4 M).
- Taux de mortalité infantile = décès <1 an/naissances vivantes ; **4,1 ‰** en 2024.
- Pour la 1ère fois en 2025, décès > naissances (inversion non observée depuis la guerre).
- **Surmortalité masculine** globale (toutes classes d'âge).
- Dès 65 ans, décès considérés naturels/liés au vieillissement ; avant, capacité d'accompagner pour éviter le décès.

10 · CAUSES DE MORTALITÉ

p.13

- ★★ **2022 : tumeurs ≈ 27 % des décès, 1ère cause chez les hommes.**
- ★ **2022 : maladies cardiovasculaires ≈ 24 % des décès, 1ère cause chez les femmes.**
- Démences 7 %, causes externes 6 %, appareil respiratoire 2 %.
- 1980-2004 : diminution des décès cardiovasculaires (thérapeutiques, défibrillateurs) ; grande stabilité des décès tumoraux/cancers.
- Inversion des 2 premières causes : 2000 (1 cardiovasc., 2 tumeurs) → 2008 (1 tumeurs, 2 cardiovasc.).

11 · L'ESPÉRANCE DE VIE

p.14

- ★★ **Espérance de vie = nombre moyen probable d'années à vivre.**
- Hausse continue depuis les années 1970 (hommes et femmes), malgré des ralentissements récents.
- 2023 : hommes **80,0 ans** ; femmes **85,7 ans**.
- Femmes toujours avantagées ; écart réduit progressivement : 7,8 ans (1997) → 7,0 ans (2007) → 5,9 ans (2022).
- Explication : avancée médicale pour tous ; facteurs de risque des femmes désormais proches des hommes (alcool, tabac, sédentarité).
- À 35 ans : hommes cadres 44,5 ans vs hommes ouvriers 38 ans.
- À 65 ans : hausse globale, toujours plus élevée chez les femmes (écart qui se réduit).
- Baisse brutales lors des grandes guerres (surtout hommes, reprise rapide) ; décrochages socio-éco/pandémies.
- France 2024 (Europe) : femmes 85,8 ans (devant l'Allemagne, derrière l'Espagne) ; hommes 80,2 ans (idem).
- Disparités régionales : plus faible dans le nord de la France et en Outre-mer (2014).

12 · MORTALITÉ INFANTILE ET DÉMOGRAPHIE (ISF)

p.15

- Taux de mortalité infantile en augmentation : 3,6 ‰ (2018) → 4,1 ‰ (2024) — vigilance 1ère année de vie, grands prématurés.
- **Indice synthétique de fécondité (ISF)** = nombre d'enfants par femme (≠ taux de fécondité).
- Seuil de remplacement = **2,1** ; si ISF < seuil, diminution possible de la population sans apport migratoire.
- 2009→2023 : population 62,6 → **68,4 millions** (hausse) ; ISF 2,0 → **1,68** (baisse depuis 9 ans, < 1,5 en 2025).